

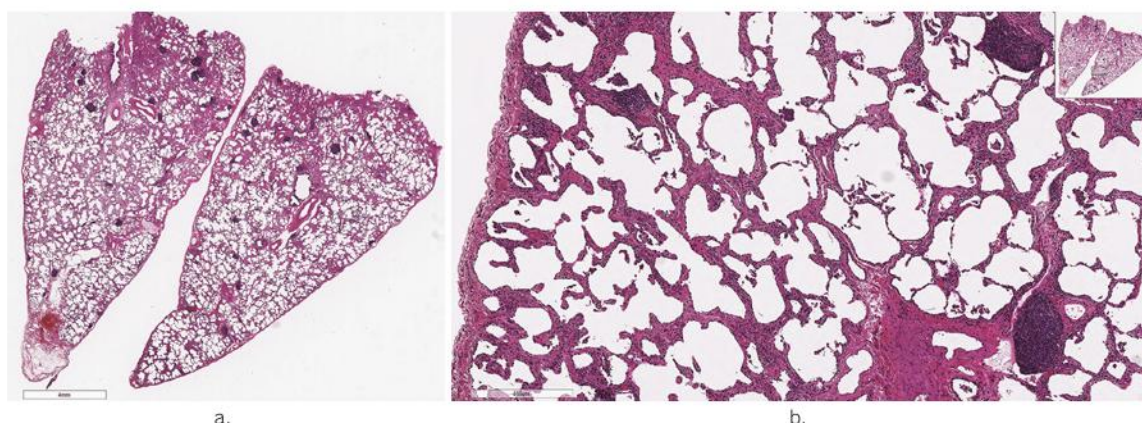


図6 fibrotic NSIPの病理所見

a: 弱拡大。病変は胸膜側から肺内側にかけて比較的均一、びまん性に分布する。b: 強拡大。小葉内でも同様の均一な広がりを示し、時相が揃っている。肺の基本構造は概ね保たれ、肺胞壁などの間質はリンパ球主体の炎症細胞浸潤や線維化による肥厚を認める。

tures (IPAF) という枠組みで捉えられることがある¹¹⁾。特に IPAF 基準を満たす NSIP は、一般に予後良好だが、経過中に膠原病が出現しないか注意する。

治療と予後

副腎皮質ステロイド薬が有効な症例が多く、その予後は IPF に比較して良好である。cellular NSIP では、副腎皮質ステロイド薬単独療法が反応性も良好であり、同薬単独療法が選択される。fibrotic NSIP の一部はしばしば再増悪を繰り返し、30%に原病関連死が認められる。fibrotic NSIP に対しては、膠原病肺と同様に副腎皮質ステロイド薬に ciclosporin や tacrolimus, cyclophosphamide などの免疫抑制薬の併用が考慮される。

NSIP と診断された症例のうち、3~17%に経過中に膠原病を発症するといわれている。診断後も、肺外の症状や身体所見の出現、自己抗体の陽転化がないかみていく必要がある。

5 年生存率は 82%と IPF と比較して予後が良好であるとされている⁹⁾。しかし、fibrotic NSIP のうち、治療抵抗性の症例も存在し、nintedanib の追加や、肺

移植が必要となる症例や急性増悪を IPF 同様に引き起こす症例がある点に留意すべきである。

文 献

- 1) Kondoh Y, et al : Respir Res 23 : 24, 2022
- 2) 日本呼吸器学会びまん性肺疾患診断・治療ガイドライン作成委員会 (編) : 特発性間質性肺炎診断と治療の手引き 2022 (改訂第 4 版), 南江堂, 2022
- 3) Raghu G, et al : Am J Respir Crit Care Med 205 : e18, 2022
- 4) Collard HR, et al : Am J Respir Crit Care Med 194 : 265, 2016
- 5) Raghu G, et al : Am J Respir Crit Care Med 192 : e3, 2015
- 6) 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策事業「びまん性肺疾患に関する調査研究」班特発性肺線維症の治療ガイドライン作成委員会 : 特発性肺線維症の治療ガイドライン 2023 改訂第 2 版, 南江堂, 2023
- 7) Travis WD, et al : Am J Respir Crit Care Med 188 : 733, 2013
- 8) Ryeson CJ, et al : Eur Respir J 42 : 750, 2013
- 9) Fujisawa T, et al : Eur Respir J 53 : pii: 1802243, 2019
- 10) Park IN, et al : Eur Respir J 33 : 68, 2009
- 11) Fischer A, et al : Eur Respir J 46 : 976, 2015